

105 年放射腫瘤科專科醫師甄審

考前題庫出題格式說明

※請依照下列步驟將考題繕打於下一頁：

1. 請依下一頁範例格式繕打考題。
2. 本格式已設定好樣式，故請依下一頁範例格式繕打，切勿更改其樣式。
3. 開始撰打考題→先於工作列上點選” 格式”，下拉式選單中點選” 樣式與格式”，該樣式的格式設定將會出現在螢幕的右方，請使用該格式來控制考題的格式。

a. 點選 Question: 可用來控制題號(題目)

b. 點選 Choice: 可用來控制答案選項，自動產生 A) B) C) D)，若續按 Enter 會繼續產生 E) F)...選項，需到樣式選項點選 Answer

c. 點選 Answer: 可用來控制答案格式(本項請再註明，出題的小組科別細項)

d. 點選 QuizLevel: 難易度

e. Ref: 參考文獻

f. Comment: 註解

6. 以上步驟若無法執行，請您用複製的方式，將下頁的範例題目複製後，貼上

15 次，然後將原內容文字刪除，保留格式，再將新的考題內容文字加入。

「請各出題委員繕打考題時，一定要使用此格式，請勿自行變更該格式」

謝謝！

「以下為範例出題格式，請各委員出題時，請以下列格式繕打，切勿變更其格式，謝謝！」

1. () 有關肺癌(Lung cancer)之描述，下列何者為誤？

- A) 目前沒有證據支持在未診斷肺癌的一般人身上進行篩檢，可以降低死亡率
- B) 肺癌是造成全球死亡人數最多的癌症
- C) 聲音沙啞是肺癌的表現方式之一
- D) 大部分的肺癌都與抽菸相關

(1 答案): A (胸腔腫瘤)

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p938-942; 2013.

(1 註解): P942, NLST: all-cause mortality was reduced in the CT screening group by 6.7% when compared with the control group ($p=.02$).

2. () 有關肺癌(Lung cancer)之診斷分期，下列何者為誤？

- A) 治療前應有病理切片，若切片結果未顯示惡性，應再次進行切片
- B) 治療前檢查應包含胸部核磁共振，因為對於肺癌分期效果最理想
- C) 治療前分期檢查應包含頭部核磁共振，因為對於肺癌分期效果最理想
- D) 治療前應考慮正子斷層攝影

(2 答案): B (胸腔腫瘤)

(2 難易度): 簡單

(2 參考文獻): Handbook of Evidence-based Radiation Oncology, Eric K. Hansen, Mack Roach III; Chapter 15, p222; 2007.

(2 註解): P222, Imaging: CT of chest and abdomen

3. () 一位 45 歲女性，診斷為非小細胞肺癌(Non-small cell lung cancer)。病人接受肺葉摘除及縱膈腔淋巴結廓清，下列何者正確？

- A) 病人經手術過後，腫瘤大小為 1.5 cm，Group 11 淋巴結有侵犯，則建議後續放射治療
- B) 病人經手術過後，腫瘤大小為 1.5 cm，Group 7 淋巴結有侵犯，則建議後續放射治療
- C) 病人經手術過後，腫瘤大小為 1.5 cm，淋巴結沒有侵犯，建議需要後續輔助治療
- D) 病人經手術過後，腫瘤大小為 5 cm，淋巴結沒有侵犯，建議不需要後續輔助治療

(3 答案): B (胸腔腫瘤)

(3 難易度): 中等

(3 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p945-942; 2013.

(3 註解): P945, Subcarinal nodes (group 7). P949, PORT meta-analysis showed an improved 5-year OS for pN2 patients.

4. () RTOG 0617 在肺癌探討兩個問題：使用 cetuximab、與最適當的放射線劑量。下列關於 RTOG 0617 的敘述，何者正確？
- A) RTOG 0617 證實 74 Gy 的效果比 60 Gy 來得理想
 - B) RTOG 0617 證實 CCRT 加上標靶藥物，其效果比單獨 CCRT 來得理想
 - C) 在 RTOG 0617 中，74 Gy 的整體存活效果比 60 Gy 還差
 - D) 在 RTOG 0617 中，使用 Cetuximab 對於急性副作用沒有影響

(4 答案): C (胸腔腫瘤)

(4 難易度): 中等

(4 參考文獻): Bradley JD, Paulus R, Komaki R, et al. Standard-dose versus high-dose conformal radiotherapy with concurrent and consolidation carboplatin plus paclitaxel with or without cetuximab for patients with stage IIIA or IIIB non-small-cell lung cancer (RTOG 0617): a randomised, two-by-two factorial phase 3 study. Lancet Oncol. 2015 Feb;16(2):187-99.

(4 註解): Median overall survival was 28.7 months (95% CI 24.1–36.9) for patients who received standard-dose radiotherapy and 20.3 months (17.7–25.0) for those who received high-dose radiotherapy (hazard ratio [HR] 1.38, 95% CI 1.09–1.76; p=0.004).

5. () 一位 54 歲男性，診斷為 T3N3M1 之小細胞癌，有肝臟轉移，根據目前的證據，下列何項建議最為適當？
- A) 接受六個療程的化學治療後，反應為 Partial response (PR)，建議接受預防性全腦照射 (PCI)
 - B) 接受六個療程的化學治療後，反應為 Progressive disease (PD)，建議接受預防性全腦照射 (PCI)
 - C) 接受六個療程的化學治療後，反應為 Partial response (PR)，建議接受預防性全腦照射 (PCI) 及胸腔放射治療
 - D) 接受六個療程的化學治療後，反應為 Progressive disease (PD)，建議接受預防性全腦照射 (PCI) 及胸腔放射治療

(5 答案): C (胸腔腫瘤)

(5 難易度): 中等

(5 參考文獻): Palma et al. Thoracic Radiotherapy for Extensive Stage Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analysis. Clin Lung Cancer. 2016 Jul;17(4):239-44.

(5 註解): This systematic review with meta-analysis of 2 randomized trials indicates that Thoracic radiotherapy (TRT) improves overall survival and progression-free survival in patients with extensive stage SCLC

6. () 一位 40 歲男性，於健檢時發現 1.5 cm 肺部腫瘤，經 CT-guide biopsy 切片報告為小細胞肺癌，全身檢查後分期為 T1N0M0。下列何者不是適當的治療？
- A) 建議化學治療，並合併放射治療
 - B) 轉介胸腔外科評估手術切除，不做後續輔助治療
 - C) 轉介胸腔外科評估手術切除，後續接受輔助化學治療
 - D) 使用立體定位放射治療 (SBRT) 治療

(6 答案): **D (胸腔腫瘤)**

(6 難易度): 中等

(6 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p966; 2013.

(6 註解): P966, Definitive surgical resection is a potential therapeutic option for early-stage (T1-2N0) SCLC.

7. () 一位 49 歲女性，被診斷前縱膈腔腫瘤，經胸腔鏡手術完整切除，術中並發現直接侵犯心包膜。病理報告為侵襲性胸腺瘤(Invasive thymoma)，沒有惡性的特徵。以下何者敘述最為正確：
- A) 分期為 Masaoka stage II
 - B) 分期為 Masaoka stage III，WHO 分類可能為 Type A 或 B
 - C) 分期為 Masaoka stage III，WHO 分類為 Type C
 - D) 分期為 Masaoka stage IV

(7 答案): **B (胸腔腫瘤)**

(7 難易度): 中等

(7 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 52, p977; 2013

(7 註解): P977, Masaoka stage III: Macroscopic invasion into neighboring organ (i.e., pericardium, great vessel, or lung)

8. () 關於肺癌的姑息性放射治療 (Palliative radiotherapy)，下列何者為非？
- A) 可以使用較短的療程，例如 30 Gy / 10 fx、甚至 20 Gy / 5 fx 之分次治療
 - B) 建議同步使用化學治療，以便提高放射治療的效果
 - C) 肺癌是造成腦部轉移最常見的原因
 - D) 針對腦部轉移，立體定位放射治療 (Stereotactic radiosurgery) 與手術切除的局部控制率約略相等

(8 答案): **B (胸腔腫瘤)**

(8 難易度): 中等

(8 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p965; Chapter 93, p1766-1767.

(8 註解): P965, An ASTRO evidence-based guideline for palliative thoracic radiation has recently been published [...] use of concurrent chemotherapy in the palliative setting is not supported by the current medical literature.

9. () 下列關於上腔靜脈症候群 (SVC syndrome) 的描述，何者錯誤？

- A) 肺癌是造成上腔靜脈症候群最常見的原因
- B) 放射治療對於上腔靜脈症候群相當有效
- C) 上腔靜脈症候群是癌症急症(oncologic emergency)，若不盡快處理會造成病人死亡
- D) 對於初診斷小細胞肺癌的病人，若上腔靜脈症候群沒有症狀，可先接受化學治療

(9 答案): **C (胸腔腫瘤)**

(9 難易度): 中等

(9 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p968-969.

(9 註解): P965, Accumulating evidence demonstrates that the course of SVC is rarely life threatening. [...] Symptoms often improve without active intervention, as collateral vessels dilate.

10. () 下列關於肺部放射治療的副作用，何者正確？

- A) 傳統放射治療，放射性肺炎 (radiation pneumonitis) 發生的機會小於 5%
- B) 病人抱怨上班時乾咳不止，經藥物治療沒有顯著改善，可能是 CTCAE Grade 1 放射性肺炎
- C) 大部分的放射性肺炎約在放射治療結束後一年時產生
- D) 接受 SBRT 的病人發生放射性肺炎的機會比傳統放射治療小

(10 答案): **D (胸腔腫瘤)**

(10 難易度): 困難

(10 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p965.

(10 註解): P969, Radiation pneumonitis (RP) occurs less commonly after SBRT in comparison to conventionally fractionated radiation.

11. () 有關 Superior sulcus tumor 之描述，下列何者為誤？

- A) 大部分組織型態為 SCC

- B) 病人常有肩膀疼痛的症狀
- C) Pancoast's syndrome 病人必定有 Horner's syndrome
- D) **Horner's syndrome 病人必定有 Pancoast's syndrome**

(11 答案): D (胸腔腫瘤)

(11 難易度): 中等

(11 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p957.

(11 註解): P957, Pancoast's syndrome is a constellation of signs and symptoms including shoulder/arm pain, Horner's syndrome, and unilateral upper extremity weakness.

12. () 針對一位 37 歲女性，KPS=100，診斷為第三期肺癌，下列處置何者較不恰當？

- A) 先進行 Preoperative chemotherapy，再手術
- B) 先進行 Preoperative chemoradiotherapy，再手術
- C) 直接進行 Definitive radiotherapy，再接受 chemotherapy
- D) 直接進行 Definitive radiotherapy，並同時接受 chemotherapy

(12 答案): C (胸腔腫瘤)

(12 難易度): 簡單

(12 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p955.

(12 註解): P955, In summary, these data strongly support concurrent chemoradiotherapy as the standard approach for patients with good performance status.

13. () 有關肺癌的放射治療設計，下列何者不是 QUANTEC 中建議的劑量限制？

- A) Mean lung dose (MLD) < 40 Gy
- B) Lung V₅ < 60%
- C) Lung V₂₀ < 30%
- D) Mean pericardial dose < 26 Gy

(13 答案): A (胸腔腫瘤)

(13 難易度): 中等

(13 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p960.

(13 註解): P960, Risk of radiation pneumonitis is < 20% when **mean lung dose (MLD) is less than approximately 20 Gy.**

14. () 有關肺癌中 Involved-field radiotherapy (IFRT)與 Elective nodal irradiation (ENI)的比較，下列何者為誤？

- A) ENI 會導致 radiation pneumonitis 的比例較高
- B) 針對第一期的肺癌，可給予低劑量的 ENI
- C) IFRT 比起 ENI 的優勢是可以給予較高的劑量
- D) 目前研究顯示 IFRT 與 ENI 對於 locoregional control 效果接近

(14 答案): B (胸腔腫瘤)

(14 難易度): 簡單

(14 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p954.

(14 註解): P954, There is ample evidence that the elective nodal basins can be safely omitted in stage I NSCLC, as there is low risk of nodal failure after IFRT either with conventional fractionated radiotherapy or SBRT.

15. () 有關 Germ cell tumor 之描述，下列何者為誤？

- A) Primary mediastinal germ cell tumor 的組織型態與 Testicular germ cell tumor 相同
- B) Primary mediastinal germ cell tumor 的預後比 Testicular germ cell tumor 差
- C) Seminoma 對化學治療及放射治療反應不佳，需要手術切除
- D) Nonseminomatous germ cell tumor 接受化學治療後若有殘存腫瘤，需要手術切除

(15 答案): C (胸腔腫瘤)

(15 難易度): 中等

(15 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 52, p985.

(15 註解): P985, Seminomas are quite sensitive to both radiation therapy and chemotherapy.